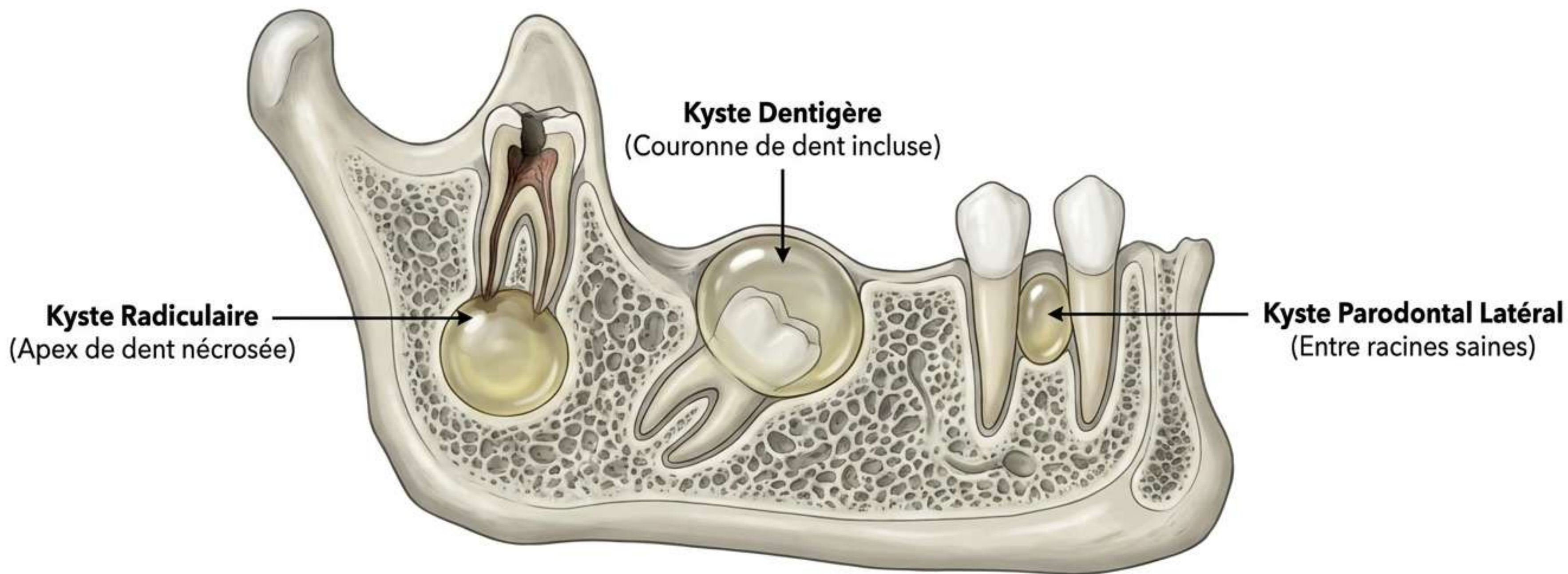


LES KYSTES DES MAXILLAIRES

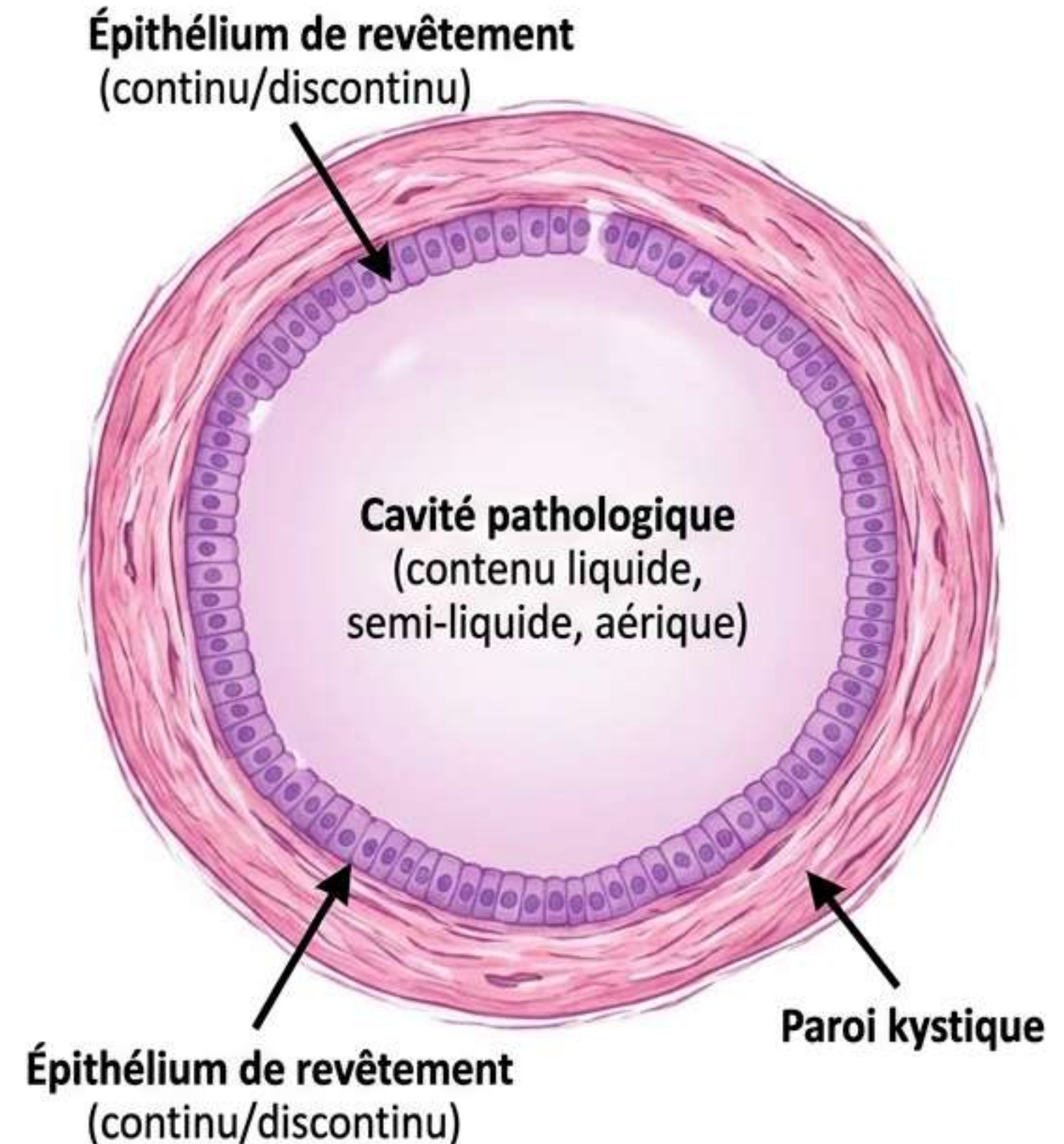
Atlas Anatomo-Clinique et Guide d'Étude Exhaustif (Basé sur le Cours de 3^{ème} Année)



Auteurs Source : Pr. Y. GUENANE / Dr. S. MAOU

Terminologie, Définitions et Origines Embryologiques

- Définition Universelle (Schear) :
 - Une cavité pathologique, bordée par un épithélium continu ou discontinu, **dont le contenu est liquide, semi-liquide, ou aérique, rarement solide et qui n'est pas créé par l'accumulation de pus.**
- Les Deux Grandes Familles :
 - **Kystes Non Odontogènes** : Se développent indépendamment du germe dentaire ou d'un épithélium lié à cet organe.
 - **Kystes Odontogènes** : Ils dérivent strictement de trois **réservoirs d'épithélium odontogénique** :
 1. Les restes épithéliaux de Malassez.
 2. L'épithélium adamantin réduit.
 3. Les résidus de la lame dentaire.[Ref: Q19 (2023), Q16 (2020), Q18 (2018)]
- Étiopathogénies Possibles :
 1. Origine embryologique (Désordre lors de l'odontogenèse / dysembryologiques).
 2. Anomalie de la structure osseuse.
 3. Association avec une dent incluse (non éruptée).
 4. Origine inflammatoire pure (Mortification de l'organe dentaire sans traitement endodontique ou traitement défectueux à l'apex).



Évolution des Classifications (De 1992 à l'OMS 2022)

Distinction en 3 groupes :
Inflammatoires,
De développement,
Non odontogènes.

1992 / 2005

Modification vers **2 groupes** majeurs :
Odontogénique d'origine inflammatoire
VS **De développement.**
Le **Kératokyste** redevient un kyste.

2017

5^{ème} classification OMS
(Vered, Wright) :
Énumération simple sans
classement strict par étiologie.

2022

Le **kératokyste parakératinosique**
était alors classé comme une
tumeur bénigne odontogène.
[Ref: Q20 (2017)]



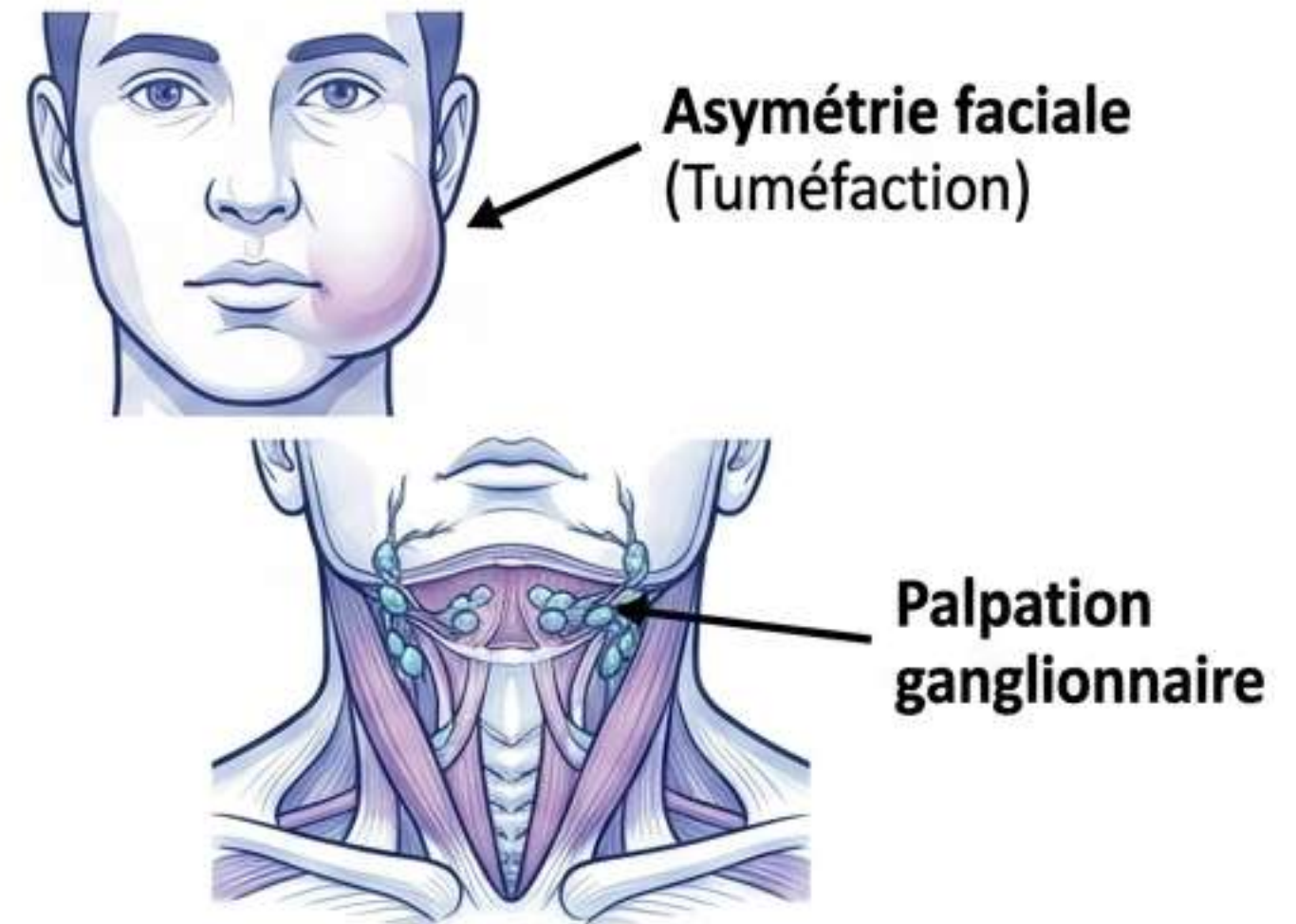
NOUVEAU :
Intégration **nouvelle et exclusive** du
Kyste Cilié Chirurgical, absent des
anciennes classifications.
[Predicted – Ajout majeur du Professeur]

Démarche Diagnostique Phase 1 : Anamnèse et Examen Exo-buccal

1. L'Interrogatoire (Anamnèse) - Facteurs Clés :

- **Âge, état civil, antécédents** médicaux/chirurgicaux.
- **Histoire de la maladie** : évolution, circonstances d'apparition, facteurs déclenchants.
- **Obstruction nasale** (spécifique aux kystes maxillaires par compression).
- **Fièvre ou asthénie** (indique une surinfection).
- **Traumatisme alvéolo-dentaire infantile** (provoque une mortification lente).
- **Douleurs** (irradiées ou non) et **troubles de la sensibilité** (compressions nerveuses réversibles).
- **Notion d'écoulement caractéristique** : Liquide citrin à travers une **fistule buccale** (différent du pus pur).
[Predicted – Signe distinctif]

2. Examen Exo-Buccal :

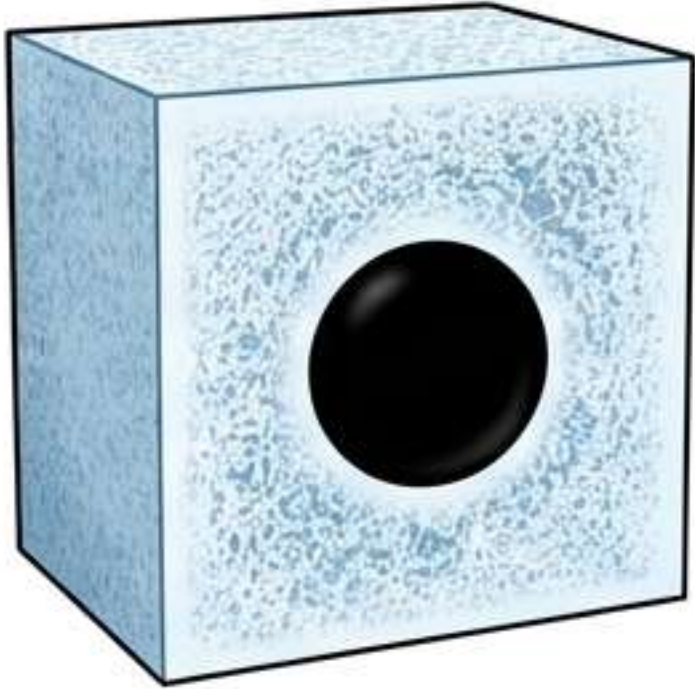


Si positive, **adénopathies mobiles et douloureuses** = origine inflammatoire bénigne. Une adénopathie dure, fixe et indolore = origine tumorale maligne. [Predicted]

Démarche Diagnostique

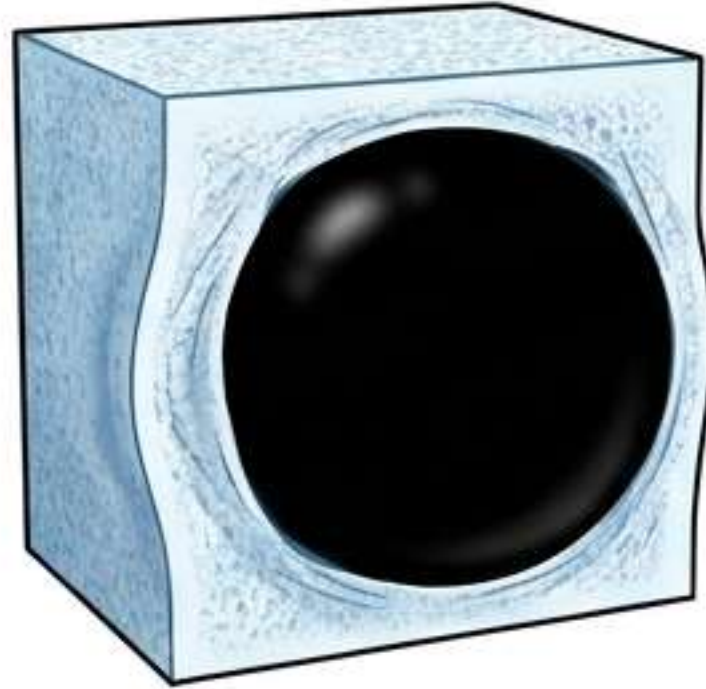
Phase 2 : Les 4 Stades de l'Examen Endo-buccal

1. Latence



Découverte fortuite radiologique.
Test de vitalité (froid) oriente vers la nécrose.

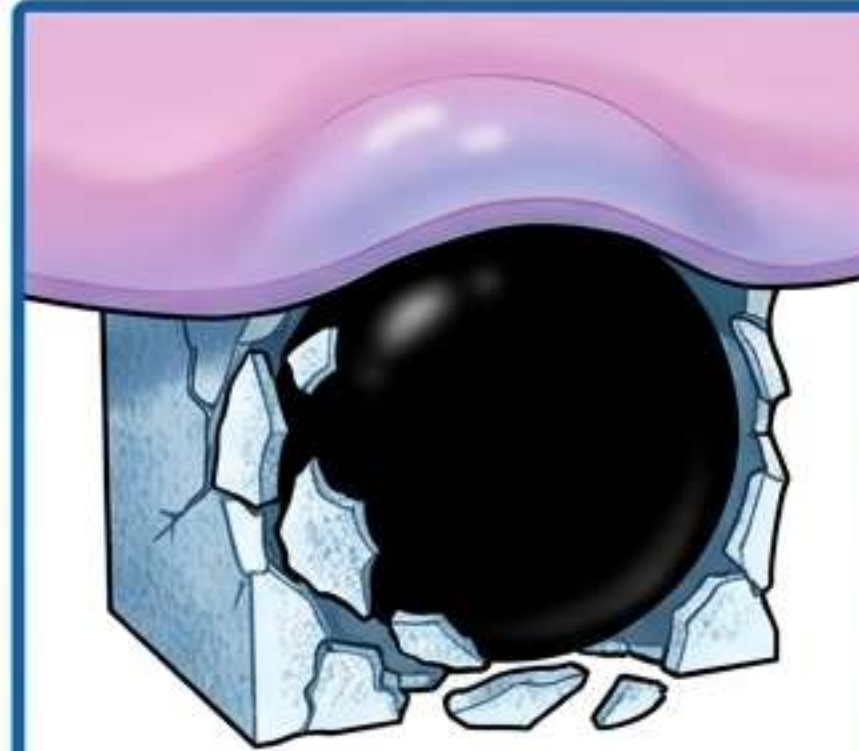
2. Déformation



Signe pathognomonique à la palpation : Consistance en 'Balle de Ping-Pong' (crépitement dû à l'amincissement en lamelle des tables osseuses). [Predicted]

Signes dentaires : mobilités, dyschromies.

3. Extériorisation



Rupture de la table osseuse.
Tuméfaction bleutée.
Consistance molle et fluctuante.

4. Fistulisation



Pression perce la muqueuse.
Écoulement de liquide citrin à paillettes de cholestérol.

Phase de Complications : Épisodes infectieux (cellulites), fractures pathologiques, compressions nerveuses, perte dentaire.

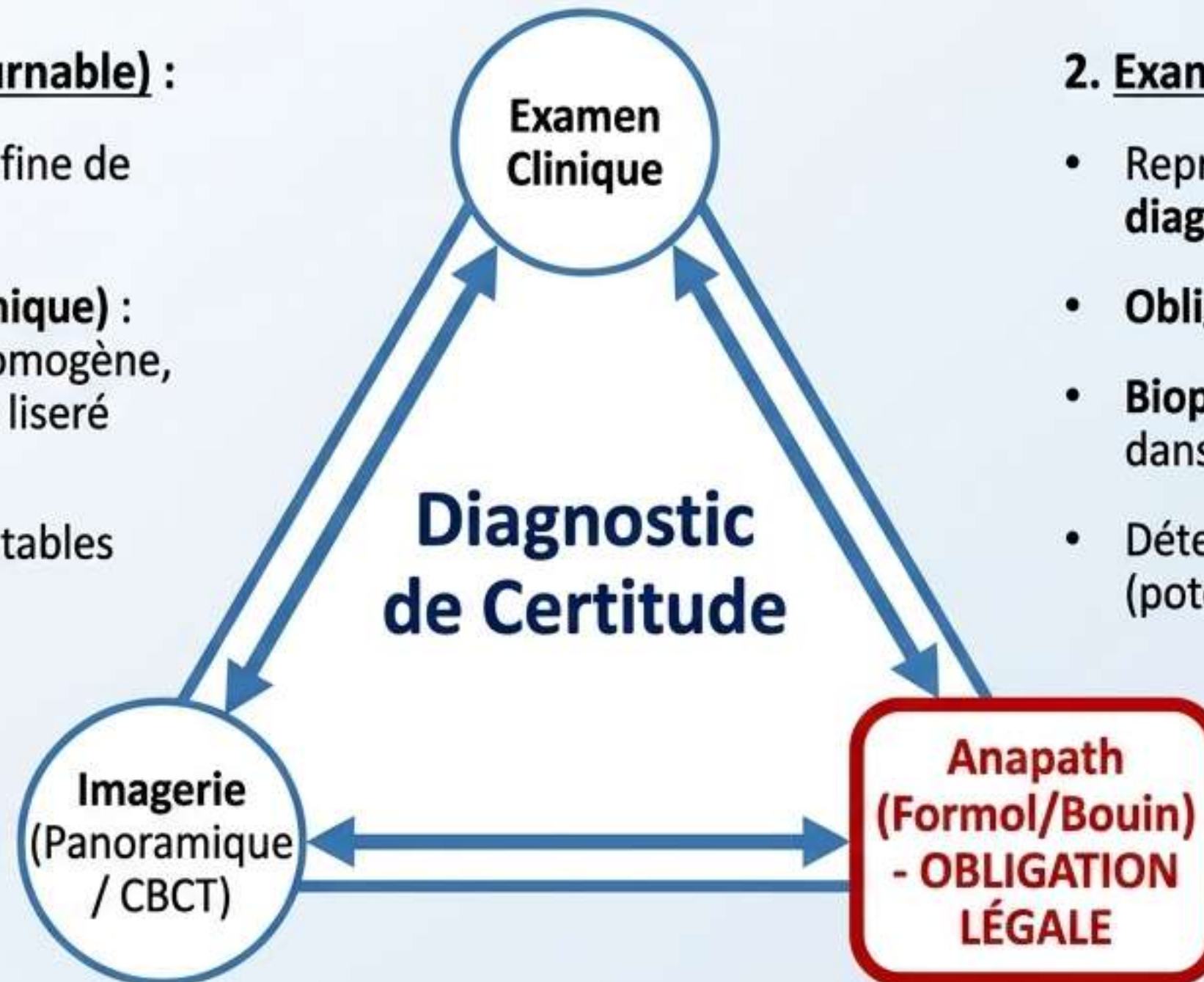
Examens Complémentaires : La Triade de Certitude

Le **diagnostic de certitude absolue** d'un kyste maxillaire repose sur l'**indissociabilité** de la **clinique**, de la radiographie, et de l'Analyse Anatomopathologique.

[Ref : Q15 (2025), Q19 (2017)]

1. Arsenal Radiologique (Incontournable) :

- **RVG / Rétro-alvéolaire** : Analyse fine de l'apex, espace desmodontal.
- **Orthopantomographie (Panoramique)** : Image radioclaire (noire/vide), homogène, monogéodique, ceinturée par un liseré d'ostéocondensation.
- **Cliché Mordu Occlusal** : État des tables corticales.
- **TDM ou Cone Beam CBCT** : 2^{ème} intention. Remplace le scanner (faible irradiation). Coupes 3D pour rapports radiculaires, dents incluses et limites exactes.



2. Examen Anatomopathologique :

- Représente la **seule certitude diagnostique**.
- **Obligation médico-légale absolue**.
- **Biopsie exérèse** fixée immédiatement dans le formol ou le liquide de Bouin.
- Détermine le **suivi post-opératoire** (potentiel de récurrence agressive).

Kystes Inflammatoires : Kyste Radiculaire et Kyste Résiduel

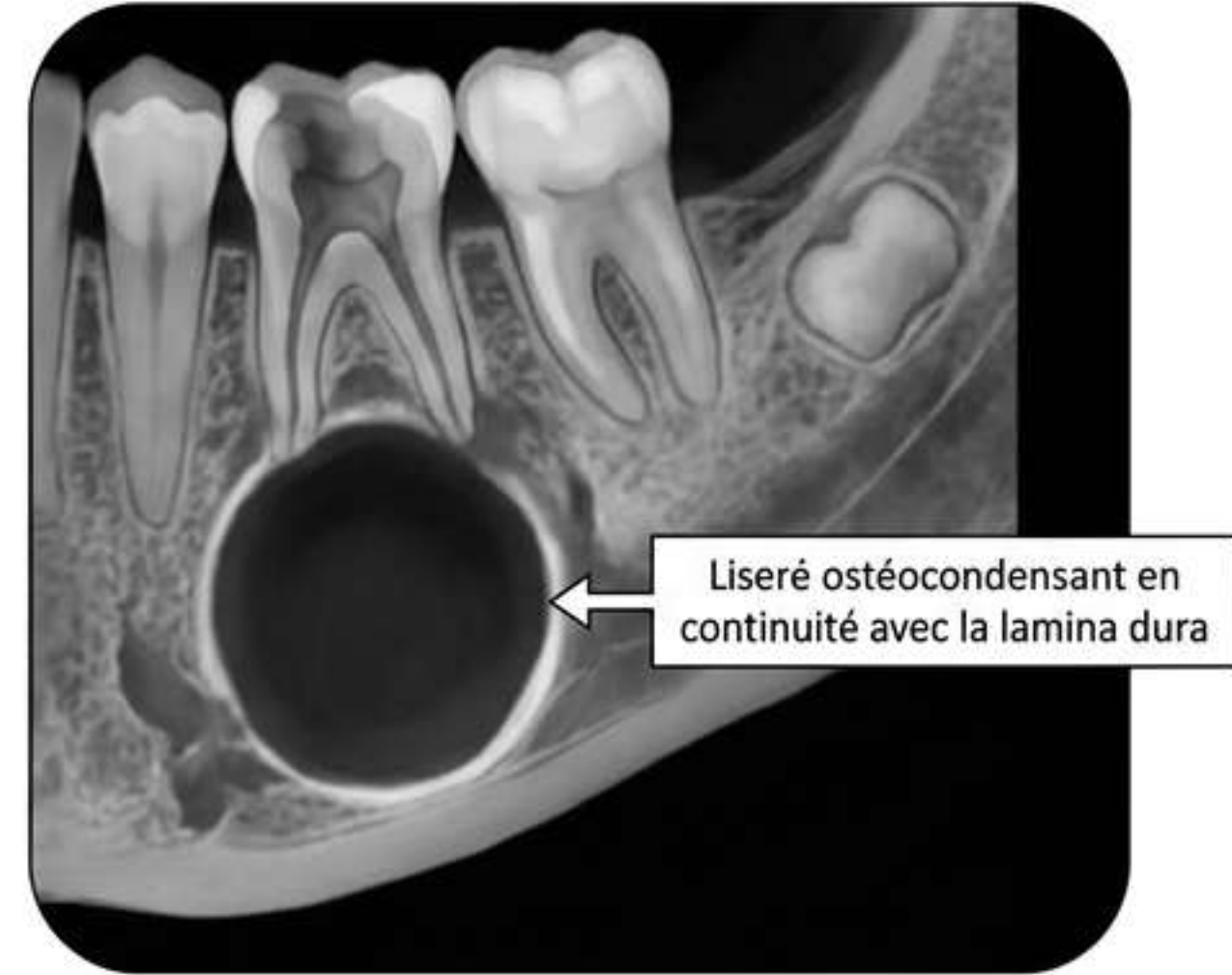
1. Le Kyste Radiculaire (Péri-apical / Dentaire Inflammatoire)

- **Épidémiologie** : 55% des kystes odontogènes. **Max de fréquence** : **40-50 ans**. Maxillaire supérieur antérieur (50%).

Fait suite aux complications **infectieuses** des **pulpopathies** : mortification/nécrose pulpaire non traitée. Formation d'un granulome qui se transforme en kyste.

[Ref: Q16 (2025), Q12 (2017), Q40 (2022)]

- **Clinique** : Test vitalité au froid négatif (Dent mortifiée). Asymptomatique.
- **Radiologie** : Géode unique radioclaire. Ne résorbe pas les racines, les refoule.



2. Le Kyste Résiduel

Persiste après l'extraction de la dent causale par absence de curetage alvéolaire. [Ref: Q18 (2020)]

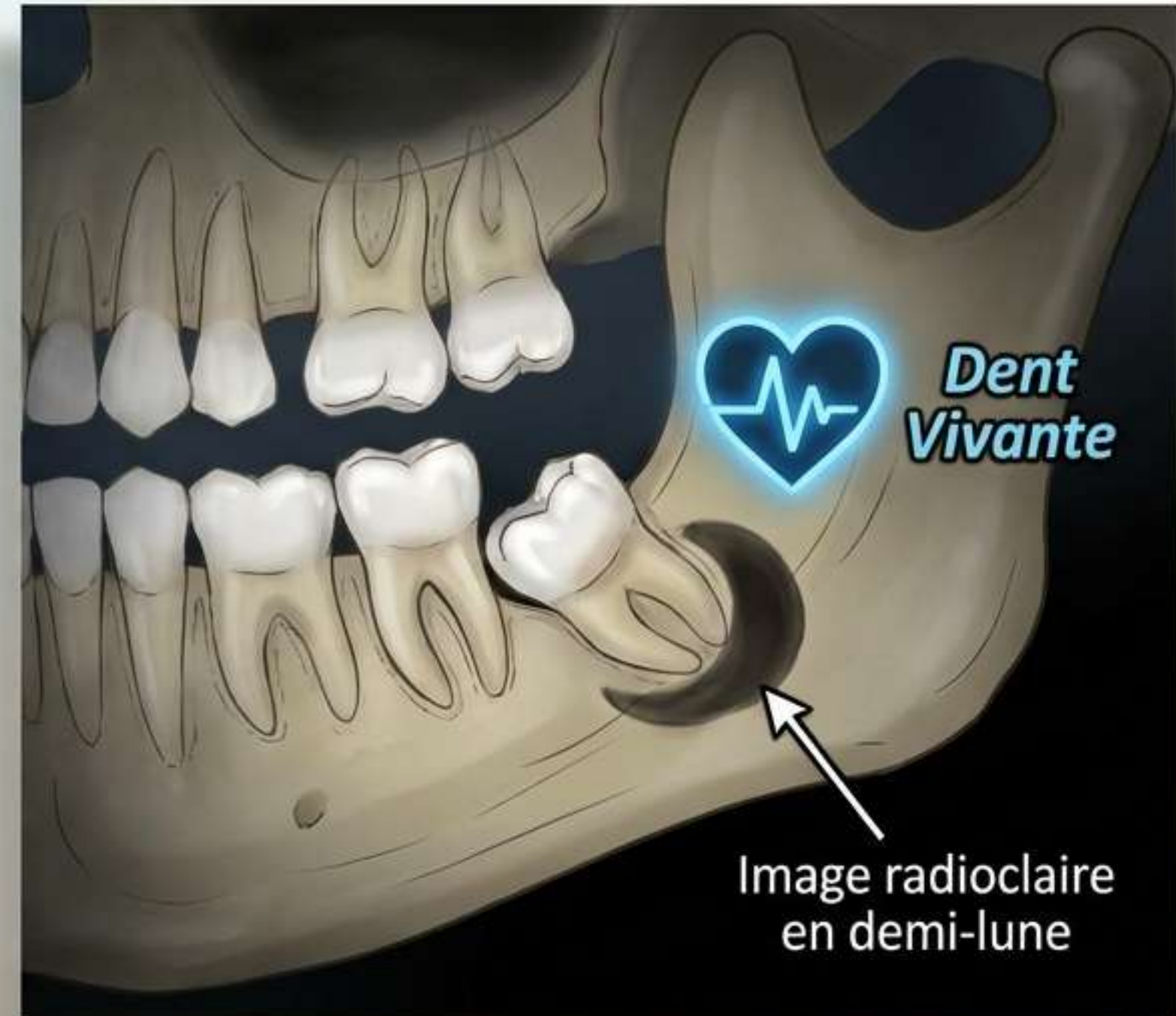
Se manifeste par une image radiologique caractéristique isolée en « carafe » sur une crête édentée. [Ref: Q2 (2016)]



Kystes Inflammatoires : Le Kyste Collatéral

Le Kyste Inflammatoire Collatéral (Kyste Parodontal / Bifurcation Buccale)

- **Épidémiologie** : 5% des kystes odontogènes. 20-40 ans. Ratio Homme/Femme 2/1.
- **Étiopathogénie** : Lié à une inflammation des tissus péri-coronaires (péricoronarite récidivante) entourant le sac folliculaire d'une dent en cours d'éruption.
- **Localisations Spécifiques** : Face vestibulaire des dents VIVANTES en cours d'éruption (3èmes molaires inférieures inférieures : 60% des cas).
- **Clinique** : Poche parodontale vestibulaire douloureuse et suppurée après péri-coronarite.
- **Radiologie** : Image radioclaire très spécifique en forme de demi-lune en distal ou disto-vestibulaire. Liseré ostéocondensant situé au voisinage du collet.
- **Histopathologie** : Épithélium non kératinisé (superposable au kyste radiculaire).



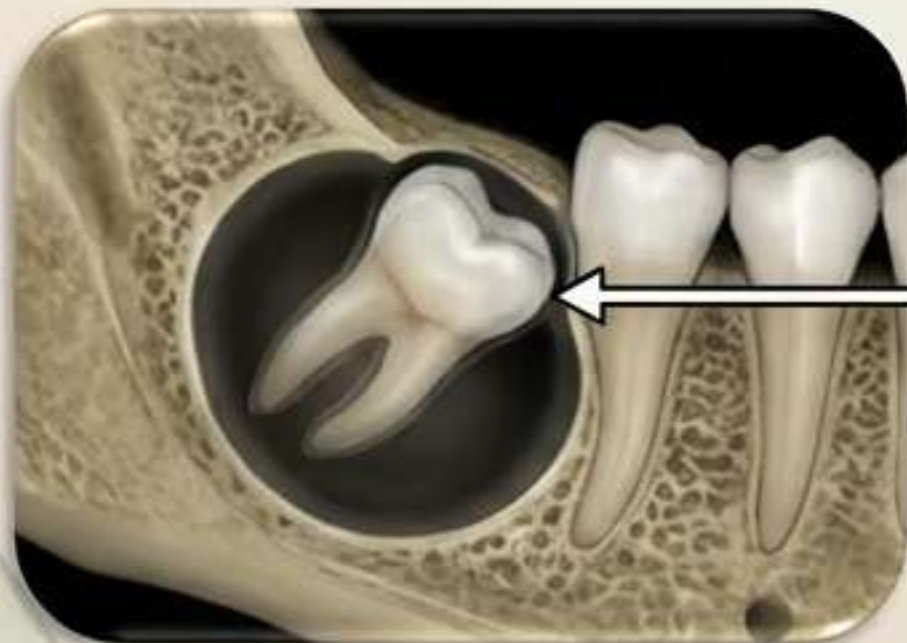
Kystes de Développement : Dentigère et Kyste d'Éruption

1. Le Kyste Dentigère (Folliculaire)

- **Épidémiologie** : 2^{ème} kyste le plus fréquent (25%).
- **Pathogénèse** : Accumulation de fluide entre l'épithélium de l'émail réduit et la couronne d'une dent incluse (3^{èmes} molaires mandibulaires, canines maxillaires).

La persistance de dents temporaires et l'absence d'une dent définitive sur l'arcade doit faire suspecter un kyste dentigère. [Ref: Q20 (2018)]

- **Radiologie** : Image radioclaire symétrique s'attachant exactement au collet de la dent incluse.



Insertion
exacte au
collet

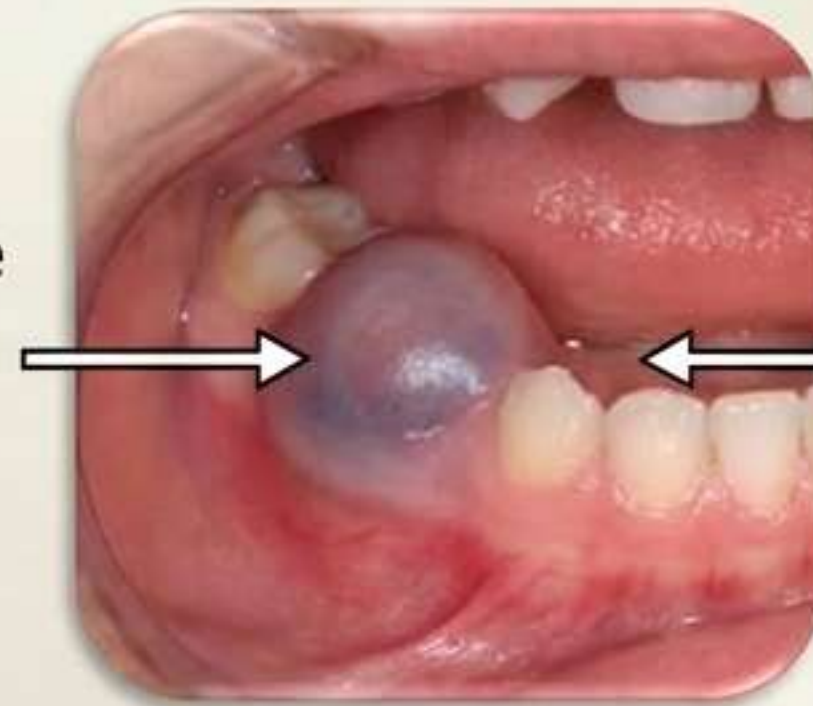
2. Le Kyste d'Éruption

Souvent retrouvé chez le jeune enfant, cliniquement assimilé à un hématome de l'éruption (voussure d'aspect bleuté/violacé en regard d'une dent retenue). [Ref: Q16 (2024), Q17 (2020), Q15 (2019)]

- **Radiologie** : Aucune traduction radiologique.

Le traitement fait appel le plus souvent à l'abstention (résolution spontanée) ou à une simple incision muqueuse. [Ref: Q16 (2024), Q15 (2019)]

Hématome
d'éruption
(Voussure
bleutée)



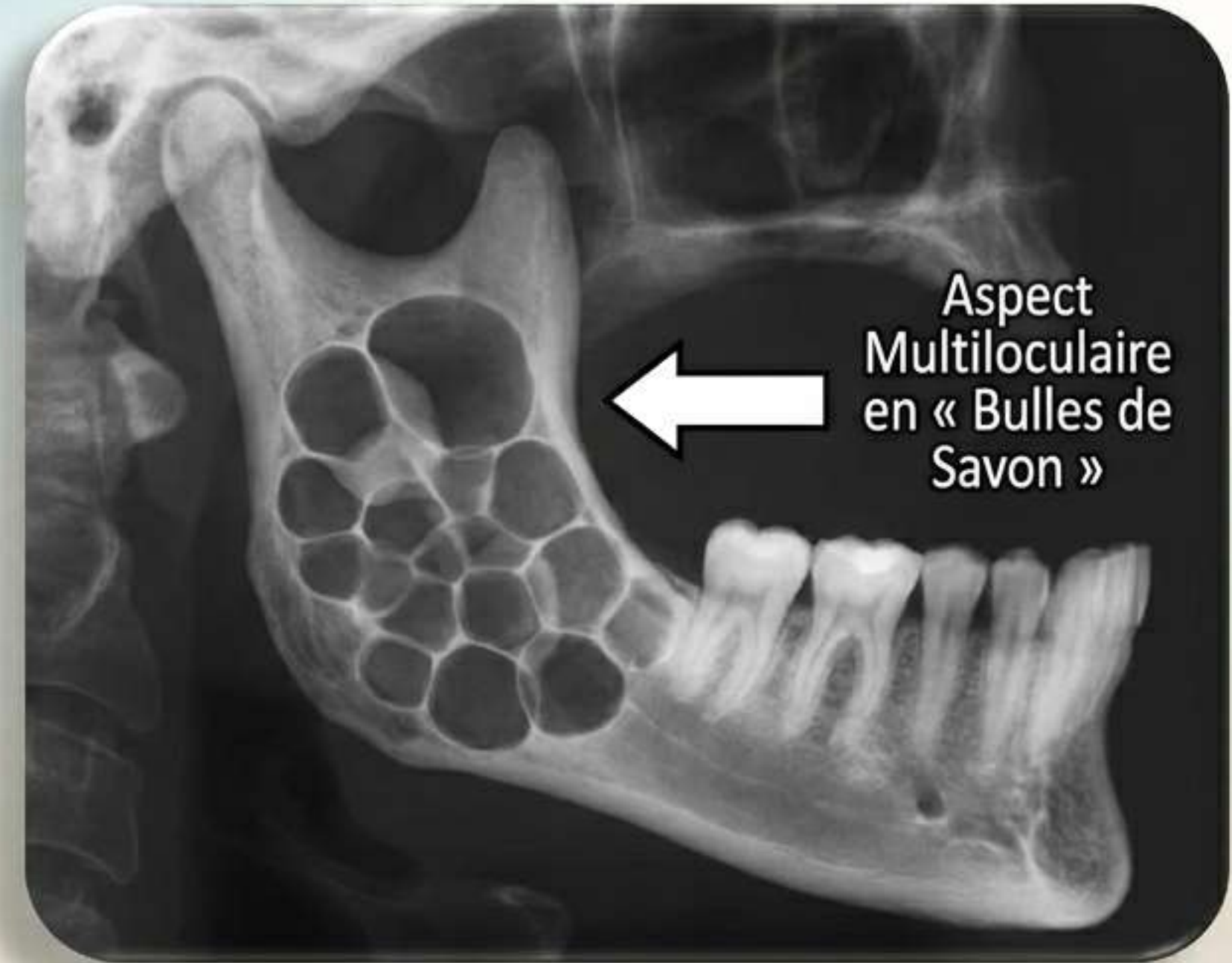
Hématome
d'éruption
(Voussure
bleutée)

Kystes de Développement : Le Kératokyste Odontogénique

- Anciennement classé comme **Tumeur Odontogène Kérato-kystique** (OMS 2005).

Se développe aux dépens des restes de l'épithélium odontogène. [Ref: Q20 (2023)]

- Épidémiologie** : 20-30 ans. Sex-ratio 1.5/1 (Homme).
- Clinique** : Très agressif localement, taux de récurrence élevé (jusqu'à 60%). Contient un liquide en « purée de poix » à paillettes de cholestérol.
- Le Syndrome de Gorlin-Goltz** : La présence de kératokystes multiples signe la nævomatose basocellulaire.
- Préférentielle à la mandibule (80% des cas), secteur postérieur (angle et branche montante jusqu'à l'échancrure coronoïde). [Ref: Q15 (2017)]
- Histologie** : Épithélium malpighien kératinisé très mince, reposant sur des cellules basales hyperchromatiques. [Ref: Q20 (2023)]



ATTENTION : Agressif / Récidive 60% / Syndrome Gorlin-Goltz

Variantes Kystiques : Ortho-kératinisant, Parodontal Latéral et Botryoïde

1. Kyste Odontogénique Ortho-Kératinisant

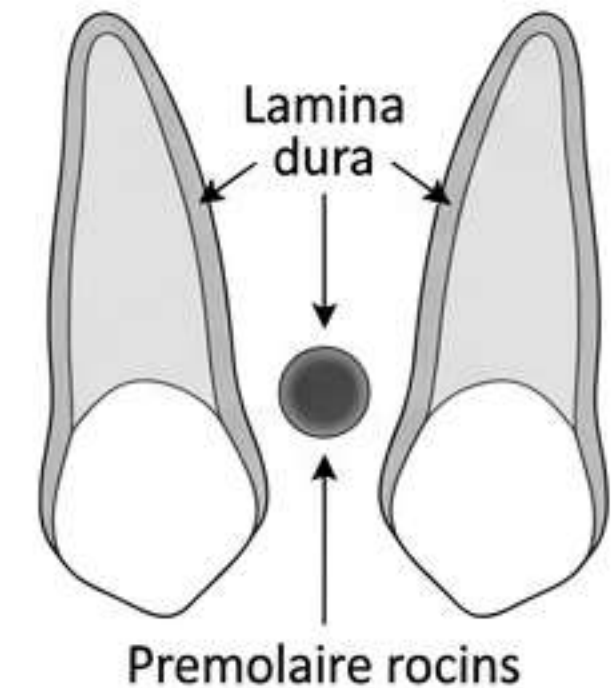
- **Profil** : Très rare (<1%). Moyenne d'âge 35 ans.
- **Différences Majeures avec le Kératokyste** : Taux de récurrence très faible (2-5%). Jamais associé au syndrome de Gorlin. Épithélium malpighien orthokératinisant.
- **Imagerie** : Mandibule postérieure (80%), uniloculaire, très souvent associé à une 3^{ème} molaire incluse.

2. Kyste Parodontal Latéral & Variante Botryoïde

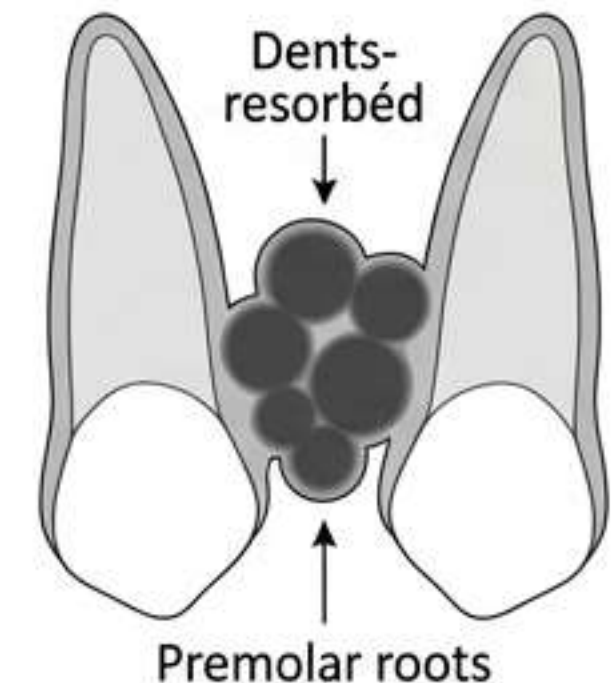
- **Épidémiologie** : Rare (<1%). Espace proximal entre les racines de 2 dents VIVANTES (canine-prémolaire mandibulaire).
- **Radiologie (Parodontal Latéral)** : Infracentimétrique, isolée entre les racines. Ne résorbe pas les racines adjacentes.

Variante Botryoïde : Version multiloculaire du kyste parodontal latéral, formant des confluences radioclares en aspect de « **grappes de raisins** ». Dents déplacées mais rarement résorbées. [Predicted]

A : Parodontal Latéral (Uniloculaire)



B : Kyste Botryoïde (Multiloculaire en grappe de raisins)



Kystes de Développement : Glandulaire, Gingivaux et Calcifiant

1. Kyste Glandulaire Odontogénique (Sialo-odontogène)

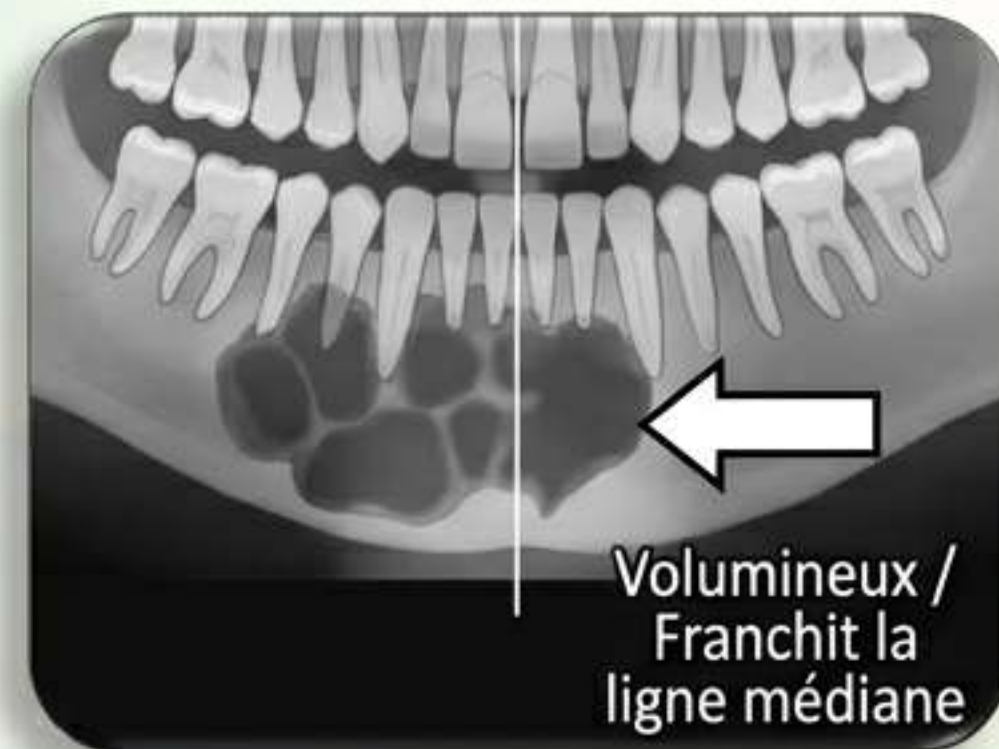
- **Spécificité** : Différenciation glandulaire, épithélium muco-sécrétant. Mandibule antérieure (80%).
- **Comportement** : Taux de récurrence très élevé variant de 20 à 30%. [Predicted]

2. Kyste Odontogénique Calcifiant (Kyste de Gorlin)

- **Spécificité** : Épithélium améloblastique comportant des « cellules fantômes » se calcifiant.
- **Génétique** : Associé de manière caractéristique à une mutation du gène CTNNB1 (codant la β -caténine). [Predicted]

3. Les Kystes Gingivaux (Extra-osseux / Aucune radio)

- **Du Nouveau-Né** (Perles d'Epstein/Nodules de Bohn) : Fréquents (90%). Crête édentée maxillaire. Papules blanches de qqs mm. Disparaissent seuls (<3 mois).
- **De l'Adulte** : Rare (<0.5%). Nodule bleuté/blanc infracentimétrique sur gencive attachée.



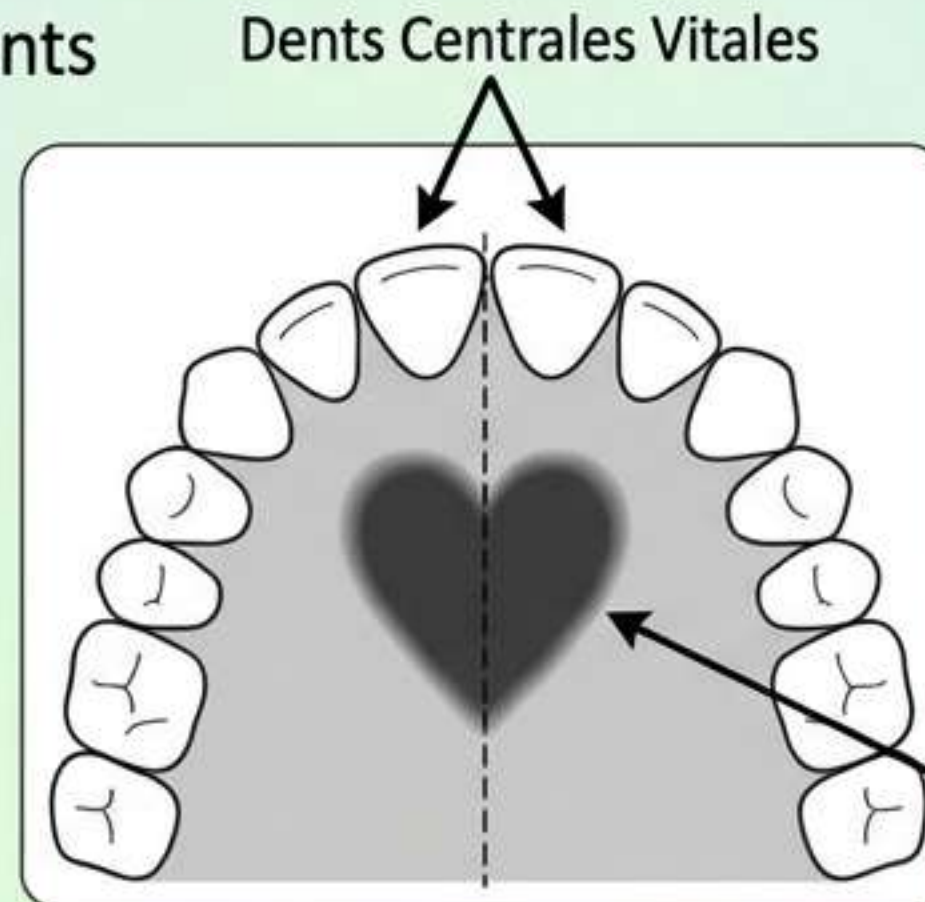
Aucune manifestation radiographique.
Non visible sur radiographie.

Kystes Non Odontogènes et Cilié Chirurgical

1. Le Kyste du Canal Naso-Palatin (Non Odontogène)

- **Épidémiologie** : 80% des kystes non odontogènes. Homme 30-60 ans.
- **Pathogénèse** : Dérive des vestiges malpighiens/respiratoires du canal incisif.
- **Clinique** : Nodule sessile postérieur aux incisives centrales maxillaires. Dents VIVANTES.

Radiologie (Cliché Mordu) : Image radioclaire très évocatrice, bien délimitée, en forme de « cœur » caractéristique ou ovoïde entre les deux centrales. [Predicted]



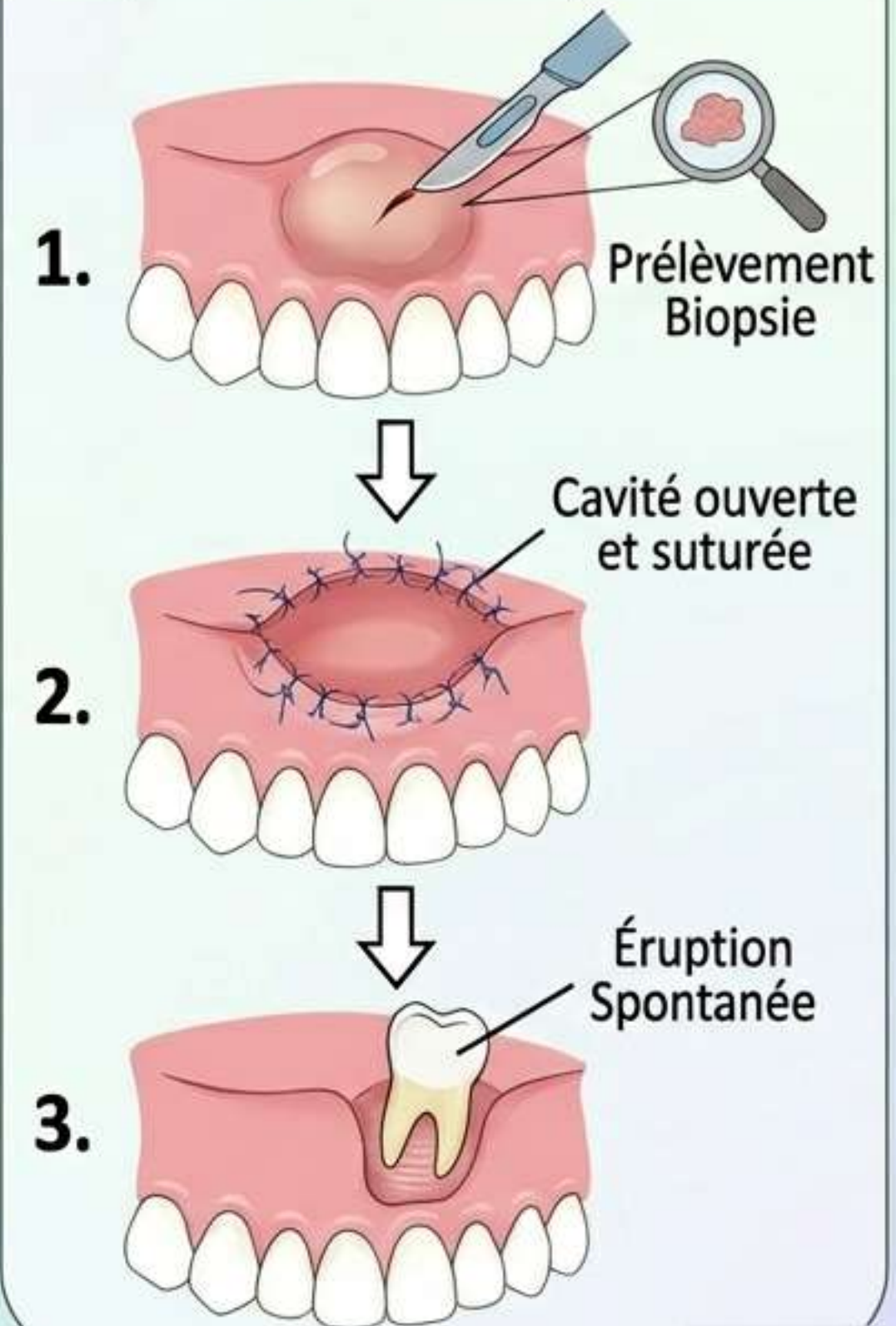
2. Le Kyste Chirurgical Cilié (Ajout OMS 2022)

- **Pathogénèse** : Implantation iatrogénique traumatique d'un fragment d'épithélium respiratoire conservant sa capacité muco-sécrétante.
- **Étiologie** : Survient des décennies (>20 ans) après une intervention : Chirurgie sinusienne (Caldwell-Luc), orthognathique, ou extraction traumatique.
- **Radiologie** : Maxillaire postérieur. Uniloculaire radioclaire, peut combler le sinus.

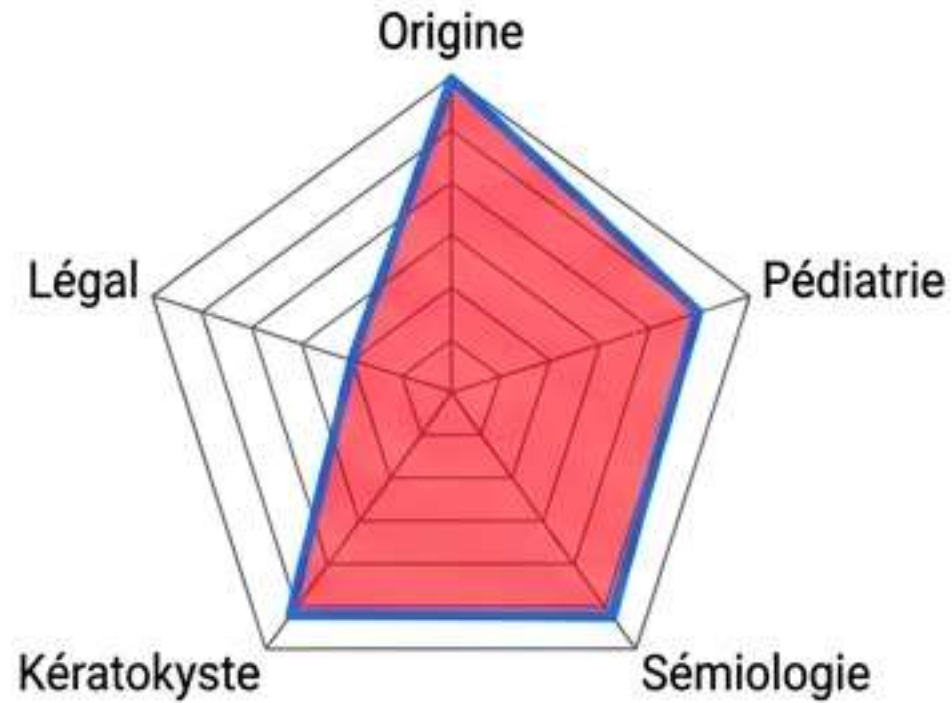
Arsenal Thérapeutique des Kystes Maxillaires

- 1. Énucléation Simple (Kystectomie) :** Pour les kystes clivables avec liseré net (Ex: Kystes radiculaires).
- 2. Énucléation avec Curetage :** Ajout d'un curetage vigoureux pour éliminer les adhérences tissulaires et réduire les récives.
- 3. Marsupialisation (Kystotomie) :**
 - Nécessite formellement une biopsie de la paroi au premier temps opératoire. [Ref: Q15/16 (2019)]
 - Transforme le kyste en cavité accessoire buccale (diminue la pression).
 - **Indication Reine :** Kyste dentigère chez l'enfant. Permet la conservation du germe et l'éruption spontanée de la dent retenue. [Ref: Q15/16 (2019)]
- 4. Décompression Chirurgicale :** Préalable à l'énucléation pour kystes géants (évite fractures).
- 5. Résections Radicales :** Kératokystes massifs ou récidivants.
- 6. Traitement Conservateur Endodontique :**
 - Pour kystes inflammatoires (radiculaire). Association traitement endodontique (dent causale) + énucléation chirurgicale. [Ref: Q17 (2025)]

Séquence de Marsupialisation



Stratégie 3^{ème} EMD & Mind Map de Synthèse



Exam Pattern Analysis

- **Origine (100%)** : Les 3 réservoirs (Malassez, Adamantin réduit, Lame dentaire).
- **Sémiologie (95%)** : Balle de Ping-Pong, Carafe, Liquide Citrin.
- **Pédiatrie (90%)** : Dentigère (Marsupialisation) vs Éruption (Abstention).
- **Kératokyste (90%)** : Odontogène, kératinisé, mandibule post, Gorlin.
- **Mise à Jour OMS (85%)** : Kyste Cilié Chirurgical (2022).
- **Diag. Certitude (100%)** : L'Anapath est la seule preuve.

